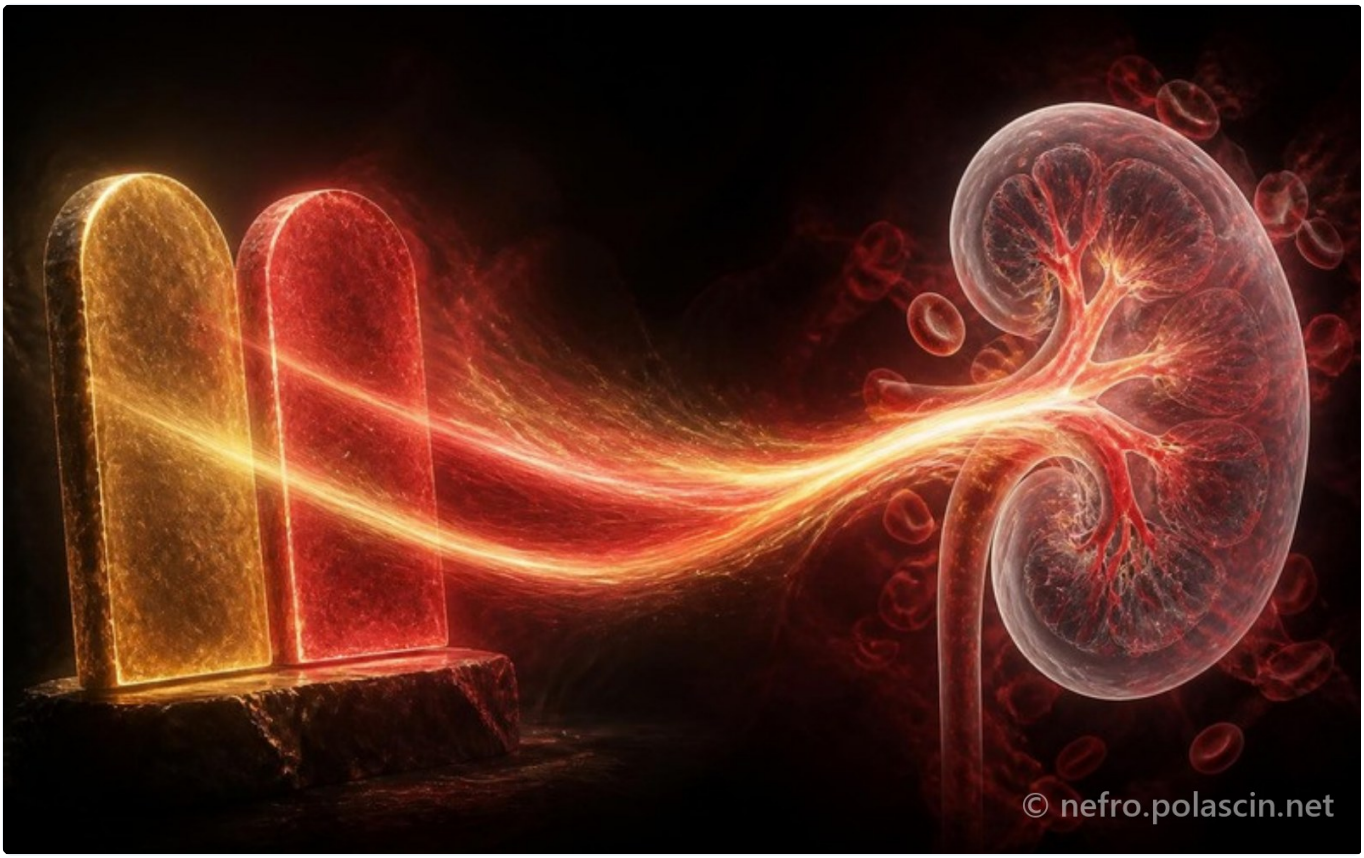
Checklist do praxe: Anémia pri CKD podľa KDIGO 2026 a KDOQI US Commentary

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Medzinárodné odporúčanie a národný komentár sa dajú spojiť do jedného použiteľného postupu.

Tento checklist zhŕňa praktický postup pri anémii u pacientov s CKD podľa KDIGO 2026 a KDOQI US Commentary. Poradie krokov: najprv potvrdiť anémiu, potom nájsť a korigovať príčinu, následne cielene riešiť železo a až potom zvažovať ESA alebo HIF-PHI.

1) Potvrdenie a základné zhodnotenie

- **Potvrdiť anémiu:** sledovať Hb a jeho trend, vrátane dátumu predchádzajúcich hodnôt.
- **Základný krvný obraz:** CBC s Hb, MCV a RDW.
- **Retikulocyty:** posúdiť produkčnú odpoveď kostnej drene.
- **Klinika:** zhodnotiť únavu, dyspnoe a toleranciu záťaže.
- **Rýchly klinický screening:** myslieť na infekciu, zápal, krvácanie a nutričný stav.

Ak výsledky a klinika nezodpovedajú typickej anémii pri CKD, netreba sa uspokojiť s jedným vysvetlením a treba myslieť aj na iné príčiny vrátane zápalu, krvácania a ďalších hematologických alebo nutričných faktorov.

2) Železo: laboratórny profil

- **Ferritín** ako základný ukazovateľ zásob železa.
- **TSAT** ako ukazovateľ dostupnosti železa pre erytropoézu.
- **Interpretácia v kontexte zápalu:** hodnoty čítať spolu s klinikou a zápalovým stavom, nie izolovane.

3) Hľadanie korektibilnej príčiny

- Ak obraz nezodpovedá anémii pri CKD, uvažovať aj o **nutričných príčinách**.

- Podľa kliniky myslieť na **hemolýzu** a ďalšie hematologické príčiny.
- Pri podozrení na krvácanie plánovať vyšetrenie zdroja podľa lokálnych možností a odborných väzieb.

Anémia v CKD je často multifaktoriálna. Kto sa zameria len na jedno číslo, ľahko prehliadne korektibilnú príčinu, ktorú by bolo možné riešiť jednoduchšie než eskaláciou ESA.

4) Rozhodnutie o železe

Hemodialýza (CKD G5HD)

- Pri kombinácii **ferritín ≤ 500 ng/ml** a **TSAT ≤ 30 %** je racionálne začať **IV železo**.
- Pri liečbe železom mať jasnú **bezpečnostnú hranicu**.
- **Rutinné železo zadržať**, ak je **ferritín > 700 ng/ml** alebo **TSAT ≥ 40 %**.

Non-HD CKD

- Zvoliť perorálne alebo IV železo podľa kombinácie ferritínu a TSAT.
- Voľbu individualizovať podľa kliniky, tolerancie, rýchlosti potreby korekcie a kontextu zápalu.

5) Špeciálne: ferric carboxymaltose a fosfát

- Pri použití **ferric carboxymaltose (FCM)** zvažovať monitoring **fosfátu**, najmä u rizikových pacientov alebo pri nových symptómoch.
- Ak sa objavia príznaky zodpovedajúce hypofosfatémii, doplniť **fosfát** a upraviť ďalší postup.

Pri opakovaných dávkach je praktické mať fosfát v pláne sledovania vopred, nie až po rozvoji príznakov.

6) Rozhodnutie o ESA a HIF-PHI

- Pred nasadením ESA alebo HIF-PHI treba mať riešené korektibilné príčiny, najmä deficit železa.
- Rozhodnutie má byť **zdieľané s pacientom** a má zohľadniť benefit, riziká aj riziko transfúzie.
- Pri CKD G5D sa ESA typicky zvažuje pri **Hb približne ≤ 9,0 až 10,0 g/dl** podľa symptómov a trendu.
- Pri udržiavaní liečby držať Hb **pod hornou hranicou približne 11,5 g/dl**.

Nehodnotí sa len samotná laboratórna hodnota, ale aj symptómy, komorbidity a bezpečnostný profil terapie.

7) Monitoring a intervaly

- **Hb, ferritín, TSAT** kontrolovať pravidelne podľa typu CKD.
- Pri CKD bez dialýzy a CKD G5PD: **každé 3 mesiace**.
- Pri CKD G5HD: **každých 1 až 3 mesiace**.
- Pri zmene klinického stavu plán revidovať, najmä pri infekcii, krvácaní, hospitalizácii alebo zhoršení výživy.

8) Dokumentácia pre spätný audit

- Zapísať aktuálne hodnoty: Hb, ferritín, TSAT a podľa potreby aj retikulocyty.
- Uviesť interpretáciu a dôvod zvoleného postupu.
- Dokumentovať hranice a odôvodnenie pri začatí alebo zadržaní železa.
- Uviesť cieľ Hb a plán monitorovania.
- Ak sa použilo FCM, zapísať dôvod voľby a plán sledovania fosfátu, najmä pri opakovaných dávkach.

Záver

Pri anémii v CKD sa checklist osvedčuje: najprv potvrdiť problém, potom hľadať korektibilnú príčinu, následne nastaviť železo s jasnými bezpečnostnými hranicami a až potom zvažovať ESA alebo HIF-PHI. Postup je prehľadný, dá sa spätne auditovať a menej zvádza k chybným skratkám.

Zdroj: *KDIGO 2026 klinická smernica pre manažment anémie v CKD a KDOQI US Commentary.* *Link na zdroj*.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=anemia-ckd-checklist-kdigo-2026-kdoqi · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.